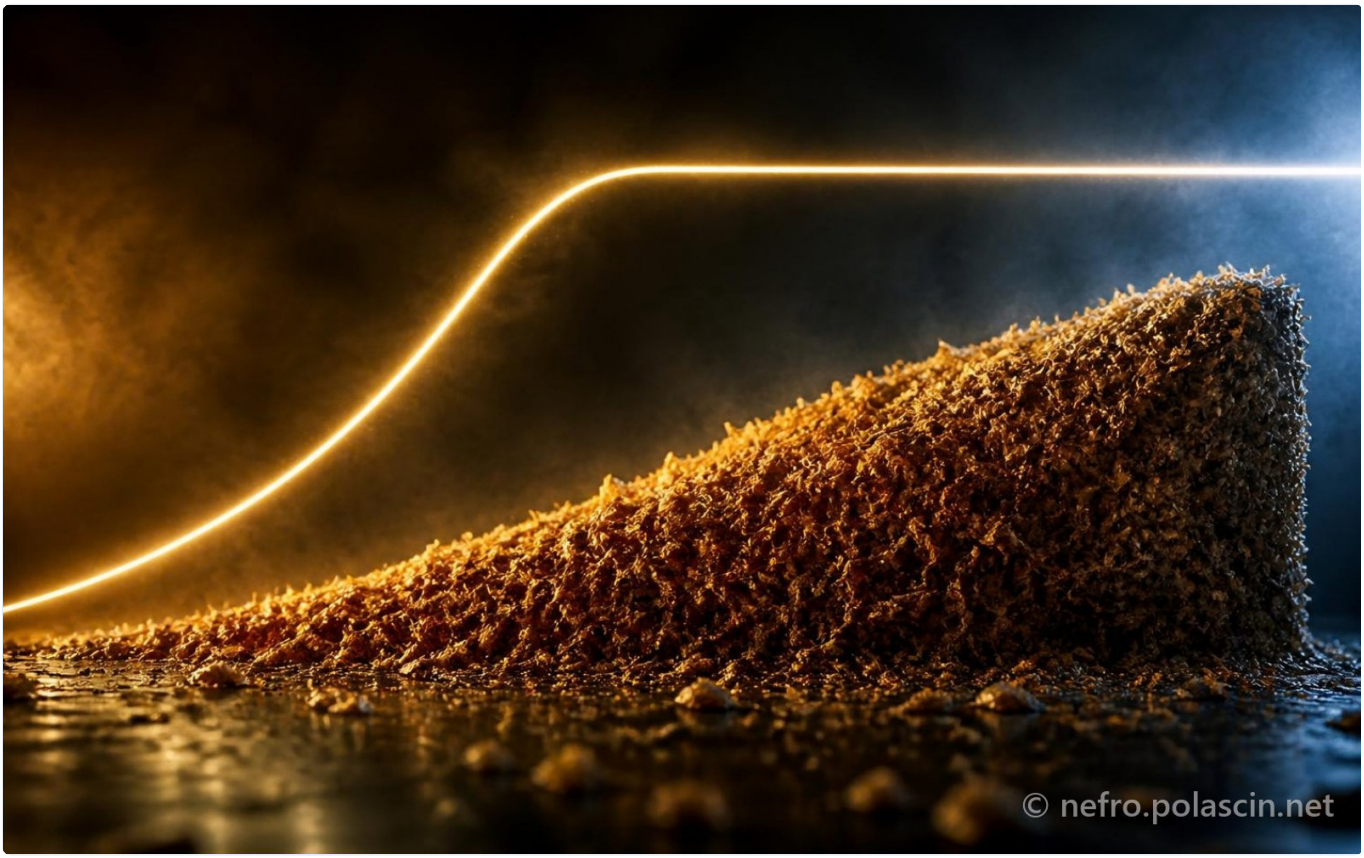
„Fibermaxxing“: vyšší príjem vlákniny prináša úžitok, otázkou je kde a pre koho sa krivka vyrovná

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 28.08.2026



Ilustračná scéna. Prvé navýšenie vlákniny prinesie najviac; ďalšie pridávanie už krivku nedvíha – a pri CKD môže pridať iné problémy.

Online trend označovaný ako „fibermaxxing“ vychádza z jednoduchej premisy: vláknina je zdravá, teda čím viac, tým lepšie. Prvá časť tejto premisy je dobre doložená. Druhá časť je problematická – a pri pacientovi s chronickou chorobou obličiek (CKD) je problematická dvojnásobne, pretože dôkazová základňa, o ktorú sa trend opiera, ľudí s chronickým ochorením výslovne nezahŕňa.

Čo dôkazy skutočne ukazujú

Najrozsiahlejším podkladom je séria systematických prehľadov a metaanalýz publikovaná v časopise *Lancet* v roku 2019. Zahrnula tesne pod 135 miliónov osoborokov údajov zo 185 prospektívnych štúdií a 58 klinických skúšaní so 4 635 dospelými účastníkmi.

Zistenie	Podrobnosť
Veľkosť účinku	Pri porovnaní najvyššieho a najnižšieho príjmu vlákniny bolo v pozorovacích údajoch riziko nižšie **o 15 – 30 %** pre celkovú a kardiovaskulárnu úmrtnosť, výskyt ischemickej choroby srdca, výskyt a úmrtnosť na cievnu mozgovú príhodu, diabetes 2. typu a kolorektálny karcinóm.
Najvýhodnejšie pásmo	Zníženie rizika bolo najväčšie pri dennom príjme vlákniny **medzi 25 g a 29 g**.
Klinické skúšania	Pri vyššom príjme vlákniny sa preukázala nižšia telesná hmotnosť, nižší systolický krvný tlak a nižší celkový cholesterol.
Kvalita dôkazov	Podľa prístupu GRADE **stredná**.

Druhým často citovaným podkladom je dávkovo-odpoveďová metaanalýza z časopisu *BMJ* (2013), ktorá zahrnula 22 kohortových publikácií. Každých ďalších **7 g vlákniny denne** sa v nej spájalo s **rizikovým pomerom 0,91** pre kardiovaskulárne ochorenie (95 % IS 0,88 – 0,94) aj pre ischemickú chorobu srdca (0,91; 95 % IS 0,87 – 0,94).

Prvá korekcia: „plateau“ nie je celkom presné slovo

Populárne prehľady z pásma 25 – 29 g/deň často vyvodzujú, že nad touto hranicou už úžitok nepribúda. Prehľad v *Lancete* však uvádza niečo iné: krivky dávky a odpovede naznačovali, že **vyšší príjem vlákniny by mohol prinášať ešte väčší úžitok** v ochrane pred kardiovaskulárnymi ochoreniami, diabetom 2. typu a kolorektálnym a prsníkovým karcinómom.

Presnejšie znenie teda je: pásmo 25 – 29 g/deň je úroveň, pri ktorej bolo zníženie rizika naprieč viacerými ukazovateľmi najkonzistentnejšie doložené – nie strop, za ktorým úžitok končí. Argument proti extrémnym dávkam preto nestojí na tom, že by boli zbytočné, ale na znášanlivosti, na chýbajúcich dôkazoch pre veľmi vysoké dávky z doplnkov a na tom, komu sa dôkazy vôbec týkajú.

Druhá korekcia, pre nefrológiu podstatnejšia: koho sa dôkazy týkajú

Autori prehľadu v *Lancete* uvádzajú výslovné obmedzenie: **zistenia sa vzťahujú na zníženie rizika v bežnej populácii, nie u osôb s chronickým ochorením**. Prospektívne štúdie aj skúšania s účastníkmi s chronickým ochorením boli z analýzy vylúčené.

To má priamy dôsledok. Pacient s CKD, ktorý si prečíta odporúčanie „25 – 29 g denne, pokojne aj viac“, čerpá z dôkazovej základne, ktorá ho nezahŕňala. Neznamená to, že vláknina je pri CKD škodlivá – existuje dobrý mechanistický dôvod pre opak. Znamená to, že prenos číselného cieľa aj očakávanej veľkosti úžitku je extrapoláciou, a že o zdroji vlákniny treba pri CKD rozhodovať inak než v bežnej populácii.

Prečo je vláknina pri CKD napriek tomu zaujímavá

Nefrologický dôvod záujmu o vlákninu nie je kardiovaskulárny, ale mikrobiálny. Pri CKD sa mení zloženie črevnej mikrobioty a posilňuje sa **proteolytická fermentácia**, pri ktorej vznikajú prekurzory uremických toxínov viazaných na bielkoviny – indoxylsulfát a p-krezylsulfát. Fermentovateľná vláknina posúva rovnováhu smerom k sacharolytickej fermentácii a produkcii mastných kyselín s krátkym reťazcom. Ide o biologicky vierohodný mechanizmus, nie o dokázaný klinický prínos: štúdie s tvrdými obličkovými ukazovateľmi chýbajú.

Praktický výber zdroja vlákniny pri CKD

Pri CKD nie je otázkou „koľko gramov“, ale „z čoho“. Bežné vysokovlákninové potraviny sa líšia v tom, čo okrem vlákniny prinášajú:

- **Draslík.** Strukoviny, orechy, zemiaky, sušené ovocie a niektoré celozrnné výrobky patria k významným zdrojom draslíka. Pri CKD s hyperkaliémiou alebo pri liečbe blokátorom systému renín-angiotenzín treba výber prispôsobiť aktuálnej kaliémii, nie ho plošne zakázať.
- **Fosfor.** Fosfor viazaný vo fytáte v celozrnných výrobkoch a strukovinách sa vstrebáva podstatne horšie než fosforečnanové aditíva v spracovaných potravinách. Z pohľadu fosfátovej záťaže je preto prirodzený zdroj vlákniny spravidla výhodnejší než „obohatený“ výrobok.
- **Tekutiny.** Objemotvorná vláknina vrátane psyllia vyžaduje dostatočný príjem tekutín. Pri obmedzení príjmu tekutín – najmä u dialyzovaného pacienta – môže jej zvýšenie zápchu naopak zhoršiť.
- **Znášanlivosť.** Nadúvanie a bolesti brucha sú časté najmä pri náhlom zvýšení dávky a pri niektorých typoch vlákniny. Postupné zvyšovanie po malých krokoch sa znáša lepšie než skoková zmena.

K často spomínanému vplyvu fytátov na vstrebávanie železa, zinku a vápnika: ide o reálny, no spravidla mierny efekt pri bežnom príjme. Klinicky významným sa stáva skôr pri veľmi vysokom príjme v kombinácii s hraničným nutričným stavom – čo je situácia, ktorá u pacienta s pokročilou CKD nastať môže.

Čo o veľmi vysokých dávkach z doplnkov vieme

Nič, čo by ich podporovalo. Neexistuje presvedčivý dôkaz, že extrémne dávky vlákniny z doplnkov prinášajú

väčší úžitok než príjem z potravy v odporúčanom pásme. Uvedené prehľady navyše hodnotili prevažne vlákninu z potravy; prenos ich záverov na koncentrovaný doplnok nie je automatický. Preferencia potravinových zdrojov pred doplnkami je preto odôvodnená aj mimo nefrologického kontextu.

Záver

Vyšší príjem vlákniny je spojený s nižším rizikom viacerých ochorení a pásmo 25 – 29 g denne je najlepšie doloženou úrovňou. „Fibermaxxing“ však robí dva myšlienkové skoky naraz: zamieňa asociáciu za návod a bežnú populáciu za všetkých. Pri chronickej chorobe obličiek platí odporúčanie v inej podobe – vlákninu áno, prednostne z potravy, s postupným zvyšovaním a s výberom zdroja podľa kaliémie, fosfatémie a povoleného príjmu tekutín.

Súvisiace články

- „Gutmaxxing“: keď sa snaha o zdravé črevo zmení na rigidný protokol
- Strava a zdravie čreva podľa influencerov: kde vznikajú najčastejšie chyby
- Indoxylsulfát a kognitívne zhoršenie pri CKD
- TMAO: črevný metabolit ako uremický toxín pri CKD
- Kontrola draslíka pri CKD: edukovať, nie strašiť
- Rastlinná strava a nižšia mortalita pri CKD

Odborné zdroje

1. Východiskový materiál: *Medscape. What Is Fibermaxxing – and Is More Fiber Always Better? 2026. Východiskový materiál; číselné údaje a závery boli overené podľa primárnych publikácií uvedených nižšie.*

2. Dávka a odpoveď, séria prehľadov: *Reynolds A, Mann J, Cummings J, Winter N, Mete E, Te Morenga L. Carbohydrate quality and human health: a series of systematic reviews and meta-analyses. Lancet. 2019;393(10170):434–445. doi: 10.1016/S0140-6736(18)31809-9. PMID 30638909. PubMed. Zdroj údajov o pásme 25 – 29 g/deň, o znížení rizika o 15 – 30 %, o tvare krivky dávky a odpovede aj o obmedzení platnosti na bežnú populáciu.*

3. Kardiovaskulárny ukazovateľ: *Threapleton DE, Greenwood DC, Evans CEL, Cleghorn CL, Nykjaer C, Woodhead C, Cade JE, Gale CP, Burley VJ. Dietary fibre intake and risk of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2013;347:f6879. doi: 10.1136/bmj.f6879. PMID 24355537, PMCID PMC3898422. Plný text.*

Poznámka k dôkazovému základu: *Bibliografické údaje, úplné autorské zoznamy a všetky číselné výsledky oboch primárnych prác boli overené 28. augusta 2026 cez PubMed z ich abstraktov. Upozornenie, že prehľad v Lancete vylúčil osoby s chronickým ochorením, a upresnenie tvaru krivky dávky a odpovede nie sú prevzaté z východiskového materiálu; pochádzajú priamo z abstraktu primárnej práce. Odporúčania pre výber zdroja vlákniny pri CKD sú odvodené zo všeobecne známych nutričných súvislostí, nie z uvedených prehľadov – tie pacientov s chronickým ochorením nezahŕňali.*

Text má odborný informačný charakter a nenahrádza individuálne nutričné poradenstvo. Úpravu príjmu vlákniny pri chronickej chorobe obličiek treba prispôsobiť štádiu ochorenia, aktuálnym laboratórnym hodnotám a povolenému príjmu tekutín.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=fibermaxxing-vlaknina-davka-odpoved-ckd · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.